AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

TRAUMATOLOGÍA

Ortopedia

15 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Generalidades de Fracturas, Fracturas Expuestas & Complicaciones

★★★ 12.1. Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización 3
★☆☆ 12.2. Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente GES 4
★☆☆ 12.3. Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente 6
★★★ 12.4. Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial 8

02 Politrauma del Aparato Locomotor, Pelvis & Raquis

★★☆ 12.5. Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz GES 9
★☆☆ 12.6. Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa GES 11

03 Extremidad Superior, Inferior & Cadera

★☆☆ 12.7. Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince 12
★☆☆ 12.8. Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral 13
★★☆ 12.9. Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles GES 14
★★☆ 12.10. Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía 15
★★★ 12.11. Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis GES 16

04 Ortopedia Infantil, Tumores & Columna

★★★ 12.12. Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica 17
★★★ 12.13. Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing GES 18
★★★ 12.14. Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño GES 19
★★☆ 12.15. Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva 20

Números que tienes que saber 22
Fármacos de primera línea 24
GES de la especialidad 24
Plan de repaso de 7 días 25
Índice por prioridad ★ 26

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

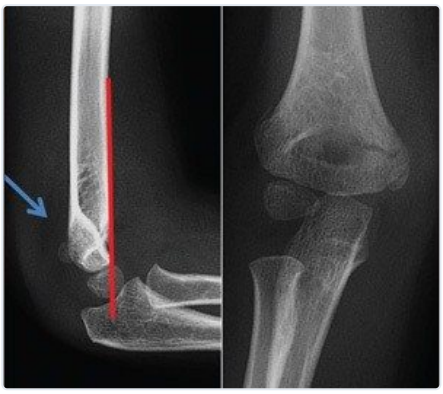
★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

4.02.2.007 Fracturas de diáfisis y metáfisis — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Inmovilizaciones de urgencia · Complicaciones de la inmovilización con yeso · Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura · Vendajes e inmovilizaciones con férulas · Fractura de la muñeca

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



ALMOHADILLA GRASA DEL CODO
Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 770

ALGORITMO · ALGORITMO DE LA FRACTURA: SOSPECHA, ESTUDIO Y TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

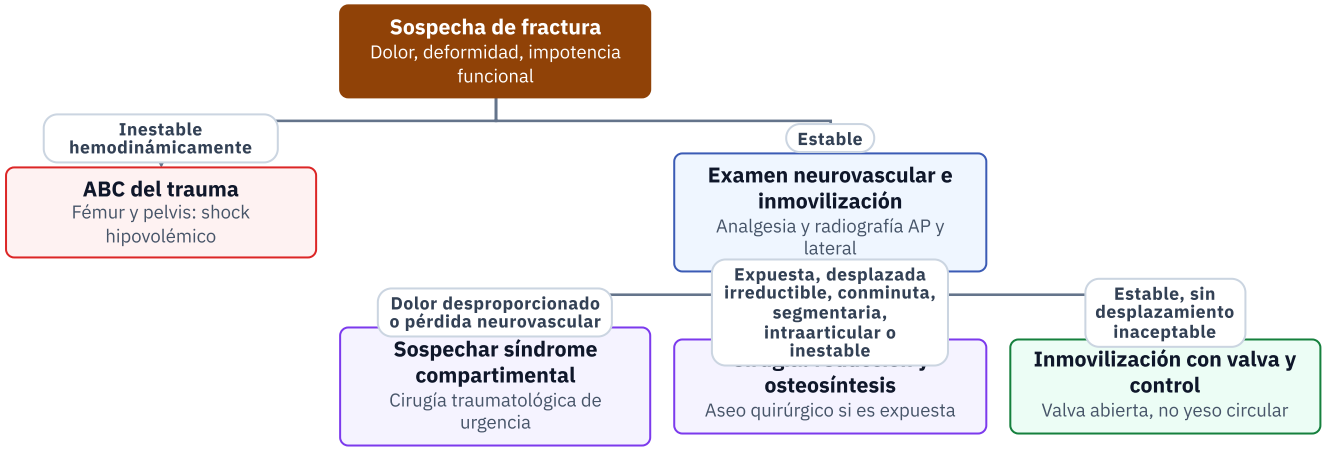


TABLA 12.1 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE PRINCIPIOS GENERALES DE FRACTURAS, CONSOLIDACIÓN ÓSEA & INMOVILIZACIÓN

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PASO	QUÉ SE HACE	ALARMA	CONDUCTA
Muñeca y yeso	Colles o tabaquera dolorosa	Radiografía normal con clínica; dedos fríos bajo el yeso	Valva o espica y repetir imagen; abrir el yeso
Cirugía	Desplazada, inestable o expuesta	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía urgente

REGLA DE ORO **ABC antes que el hueso** — Fémur y pelvis dan shock hipovolémico

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **3–9, 39–40** (págs. 8–9, 13) · solucionario págs. 20–21, 26–27.

Clase 12.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

12.2 Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta en EUNACOM · Pregunta segura sobre esquema antibiótico según Gustilo y timing de aseo

4.02.2.008 Fracturas expuestas — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Inmovilizaciones de urgencia · Traslado del traumatizado

LO QUE TE PREGUNTAN

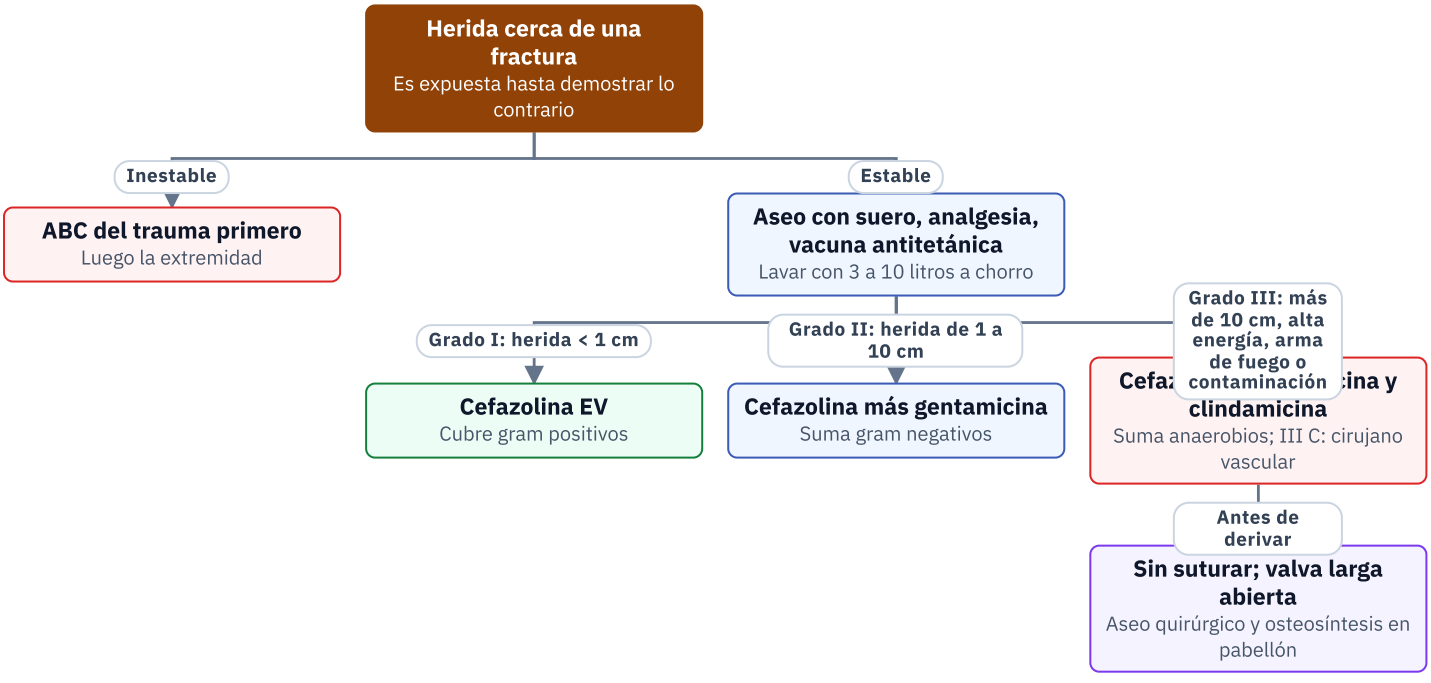
- En Fracturas Expuestas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- **La sospecha clínica manda en trauma**: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.



HERIDA AMPLIA CON HUESO
ATLS 10.ª ed., Fig. 8-6

ALGORITMO · ALGORITMO DE LA FRACTURA EXPUESTA: DEL ASEO AL TRASLADO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **10–13** (pág. 9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 12.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

12.2 Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★☆☆ PRIORIDAD BAJA

TABLA 12.2 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS EXPUESTAS

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

GRADO	COBERTURA	ANTIBIÓTICO
I	Gram positivos (S. aureus)	Cefazolina EV
II	Gram positivos y gram negativos	Cefazolina + gentamicina
III	Gram positivos, negativos y anaerobios	Cefazolina + gentamicina + clindamicina

REGLA DE ORO **Aseo abundante y antibiótico EV** — Lavado con 3 a 10 litros; primera hora

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El dominio de Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

TABLA 12.2.B · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN FRACTURAS EXPUESTAS

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **10–13** (pág. 9) · solucionario págs. 21–22.

Clase 12.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

12.3 Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta en EUNACOM · Dolor desproporcionado al estiramiento pasivo y contraindicación de yesos cerrados

4.02.2.001 Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Embolia pulmonar · Trombosis venosa profunda y tromboflebitis

LO QUE TE PREGUNTAN

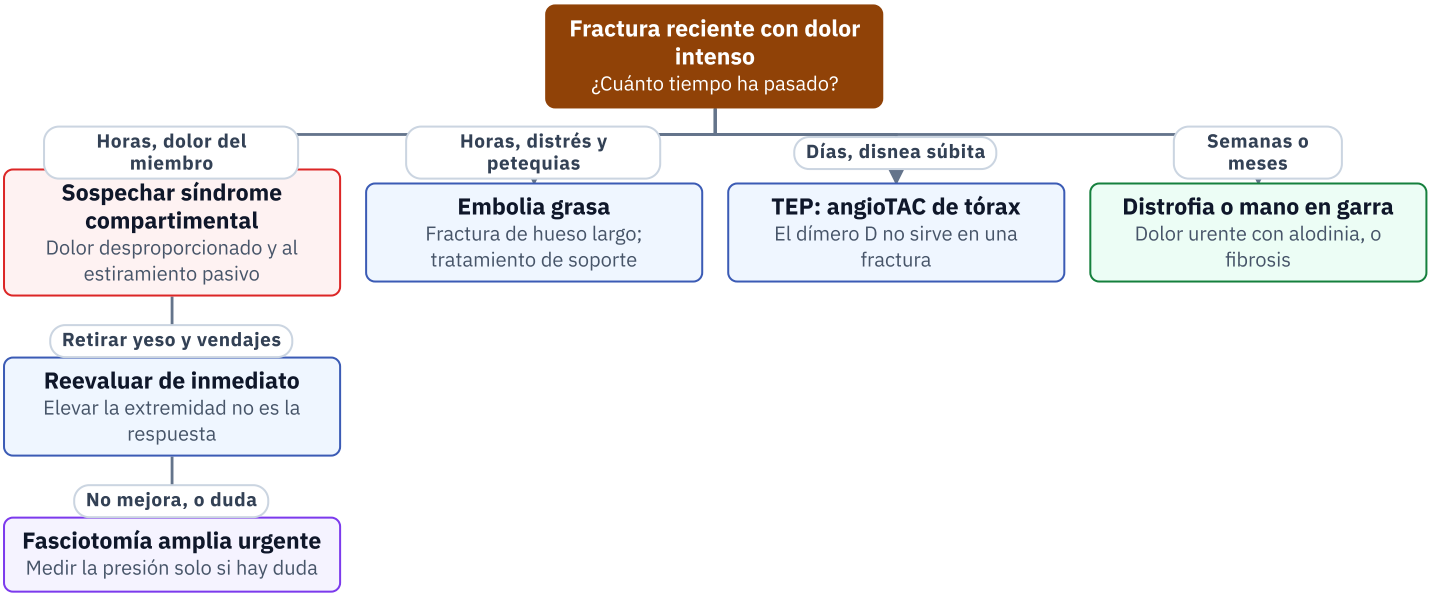
- En Síndrome Compartimental Agudo, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- **La sospecha clínica manda en trauma**: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.



FASCIOTOMÍA DEL ANTEBRAZO
ATLS 10.ª ed., Fig. 8-8A

ALGORITMO · ALGORITMO DEL PACIENTE CON DOLOR DESPUÉS DE UNA FRACTURA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **14–18** (págs. 9–10) · solucionario págs. 22–23.

Clase 12.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

12.3 Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente

PRIORIDAD BAJA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 12.3 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

CUADRO	CUÁNDO	CLÍNICA CLAVE	CONDUCTA
Síndrome compartimental	Horas	Dolor al estiramiento pasivo	Retirar yeso; fasciotomía
Embolia grasa	Horas a 48 h	Distrés, conciencia y petequias	Soporte
TEP	Días	Disnea súbita, dolor pleurítico	AngioTAC; dímero D no sirve

REGLA DE ORO **Dolor desproporcionado y al estiramiento pasivo** — Es lo más precoz; el pulso es tardío

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El dominio de Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

TABLA 12.3.B · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN SÍNDROME COMPARTIMENTAL AGUDO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **14–18** (págs. 9–10) · solucionario págs. 22–23.

Clase 12.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES

12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

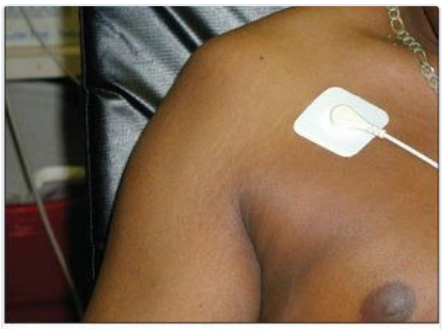
★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

4.02.2.010 Lesiones de los nervios periféricos — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Insufic. arterial aguda: embolia, trombosis, traumatismos · Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares · Traumatismos vasculares · Fracturas · Luxación del hombro · Reducción de luxaciones de codo, hombro e interfalángicas

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Lesiones Neurovasculares de las Fracturas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



HOMBRO SIN CONTORNO REDONDO
Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 542

ALGORITMO · ALGORITMO DE LA FRACTURA CON COMPROMISO NEUROVASCULAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

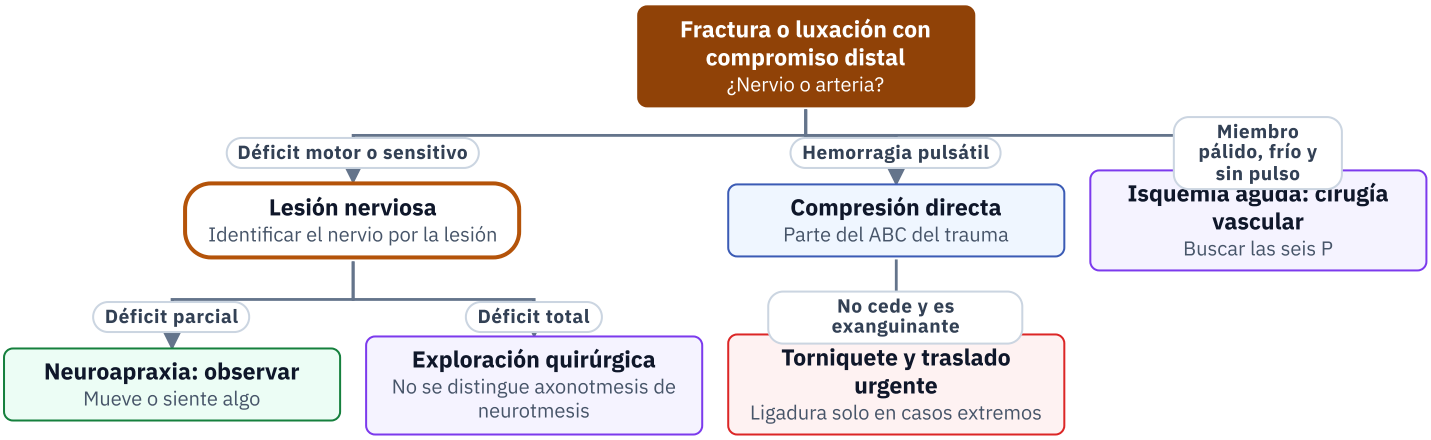


TABLA 12.4 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES NEUROVASCULARES DE LAS FRACTURAS

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

NERVIO	SE LESIONA CON	DÉFICIT	SENSIBILIDAD
Radial	Diáfisis de húmero	No extiende muñeca ni dedos	Cara posterior del miembro
Axilar	Luxación anterior de hombro	No abduce el hombro	Zona deltoidea
Mediano	Supracondílea de húmero	No flecta dedos 1 al 3	Dedos 1 al 3 y mitad del 4

REGLA DE ORO **Diáfisis humeral es radial** — Mano caída y sensibilidad posterior

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **21–22, 41–42** (págs. 10, 13) · solucionario págs. 23, 27.

Clase 12.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · POLITRAUMA DEL APARATO LOCOMOTOR, PELVIS & RAQUIS

12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
7 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta en EUNACOM · Maniobra de faja pélvica sobre trocánteres mayores y reanimación hemostática

4.02.2.006 Fractura inestable de la pelvis — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Politraumatizado · Traumatismo uretral · Set radiológico de trauma en conjunto (columna cervical, tórax, pelvis y columna)

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- **La sospecha clínica manda en trauma**: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.



FRACTURA DE RAMAS PÚBICAS
Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 645

ALGORITMO · ALGORITMO DEL POLITRAUMATIZADO CON DOLOR PÉLVICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

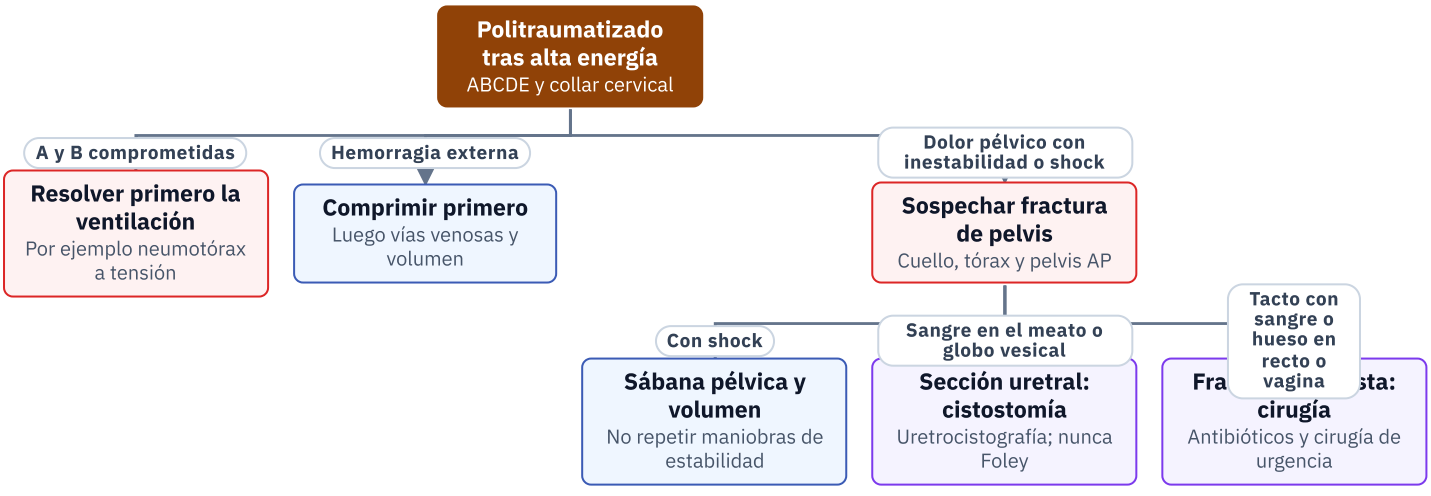


TABLA 12.5 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **20, 27–31** (págs. 10–12) · solucionario págs. 23–25.

Clase 12.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · POLITRAUMA DEL APARATO LOCOMOTOR, PELVIS & RAQUIS

12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

PRIORIDAD MEDIA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TRAMPAS EUNACOM		
SITUACIÓN	**HACES**	**NO HACES**
Pelvis inestable con shock	Volumen y estabilizar pelvis	TAC antes de actuar
Sangre en meato, próstata alta	Uretrocistografía y cistostomía	Sonda Foley
Hemorragia externa	Comprimir primero	Buscar vía antes
Politrauma, cualquier estabilidad	Cuello, tórax y pelvis	Solo tórax si está estable

REGLA DE ORO **ABCDE, sin saltarse pasos** — Collar y comprimir primero

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El dominio de Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

TABLA 12.5.B · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN FRACTURAS DE PELVIS & SHOCK HIPOVOLÉMICO PELVIANO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

ASÍ SE VE · FOTOS DE LA CLASE



PELVIS INESTABLE, MUY ANCHA
ATLS 10.ª ed., Fig. 5-9C



PELVIS ATADA CON UNA SÁBANA
ATLS 10.ª ed., Fig. 5-9B



ANILLO CERRADO TRAS LA FAJA
ATLS 10.ª ed., Fig. 5-9D

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **20, 27–31** (págs. 10–12) · solucionario págs. 23–25.

Clase 12.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · POLITRAUMA DEL APARATO LOCOMOTOR, PELVIS & RAQUIS

12.6 Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
3 preguntas reales 2013–2025

4.02.2.007 Fracturas de diáfisis y metáfisis — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



TIBIA, FRACTURA ESPIROIDEA
Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 682

ALGORITMO · ALGORITMO DE LA FRACTURA QUE NO EVOLUCIONA BIEN

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

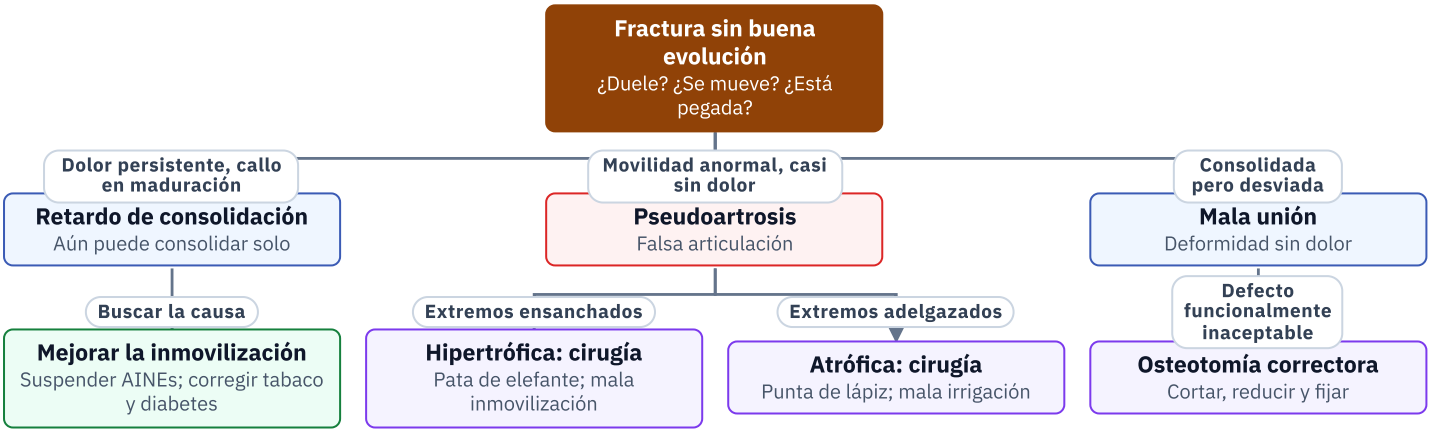


TABLA 12.6 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE RETARDO DE CONSOLIDACIÓN, PSEUDOARTROSIS & CONSOLIDACIÓN VICIOSA

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

CUADRO	DOLOR	FOCO	CONDUCTA
Retardo de consolidación	Persistente	Callo en maduración	Mejorar inmovilización
Pseudoartrosis	Casi ausente	Movilidad anormal	Cirugía
Mala unión	Ausente	Consolidado y desviado	Osteotomía si es inaceptable

REGLA DE ORO **¿Duele? Retardo** — Dolor persistente, callo en maduración

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **32–34** (pág. 12) · solucionario págs. 25–26.

Clase 12.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

12.7 Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

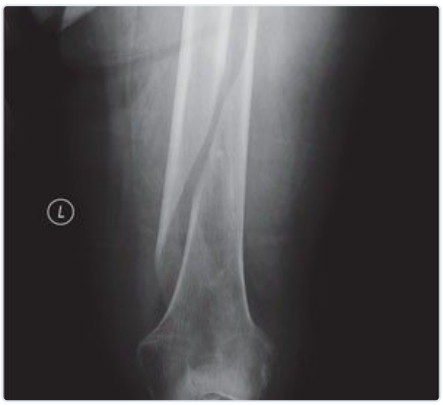
★☆☆
PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

4.02.2.013 Luxofractura del tobillo — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Esguince grado1 (acromioclavicular, dedos, rodilla y tobillo) · Fracturas de diáfisis y metáfisis · Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura · Radiografía de extremidades

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Fracturas de Extremidad Inferior, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



FRACTURA ESPIROIDEA DE FÉMUR
Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 577

ALGORITMO · LESIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR TRAS UN TRAUMA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

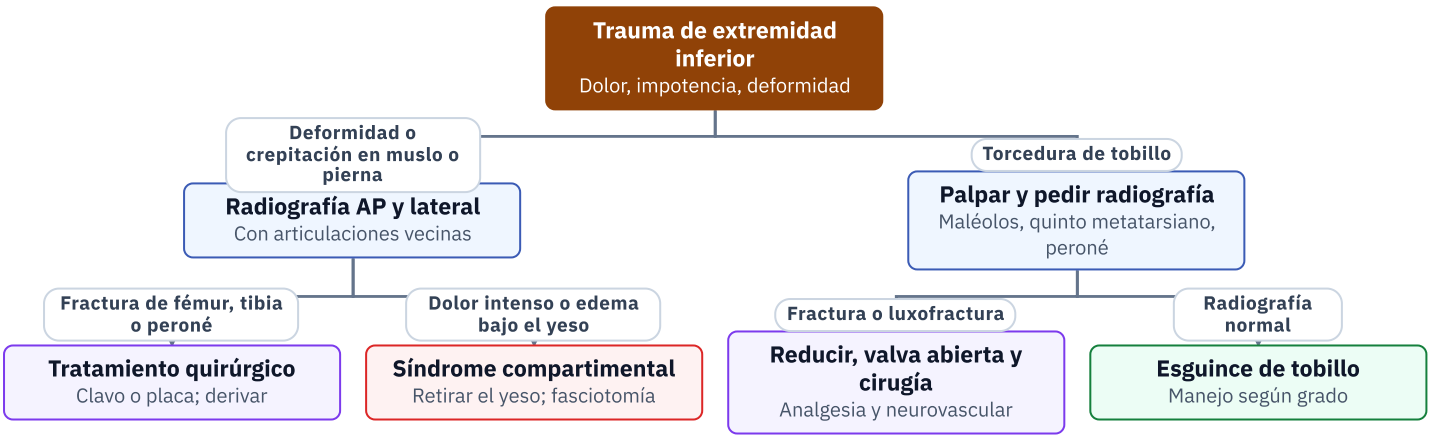


TABLA 12.7 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

SITUACIÓN	HACES	NO HACES
Torcedura con dolor o equimosis	Radiografía de tobillo	Alta como esguince sin radiografía
Fractura de tobillo confirmada	Cirugía; férula mientras	RICE con bota removible
Primera imagen del tobillo	Radiografía simple	TAC o resonancia de entrada

REGLA DE ORO **Fémur, pierna y tobillo: cirugía** — El yeso definitivo es la excepción

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **43–45, 76** (págs. 13, 17) · solucionario págs. 27, 33.

Clase 12.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

12.8 Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
4 preguntas reales 2013–2025

4.02.2.011 Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros) — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Riesgos deportivos

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Lesiones de Rodilla, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



RM: LCA Y COLATERALES ROTOS
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 32.8

ALGORITMO · DOLOR DE RODILLA TRAS UN TRAUMA O CON ACTIVIDAD

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

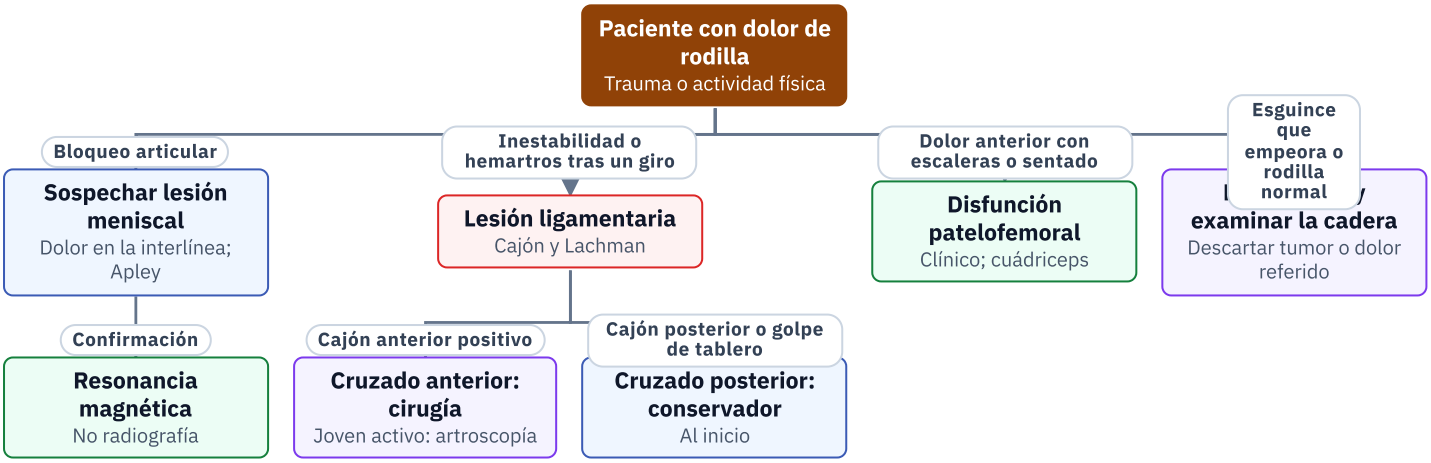


TABLA 12.8 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES DE RODILLA

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

DATO	ESTRUCTURA	EXAMEN O CONDUCTA
Bloqueo articular	Menisco	Resonancia magnética
Inestabilidad y cajón anterior	Cruzado anterior	Resonancia; cirugía en joven activo
Golpe de tablero, cajón posterior	Cruzado posterior	Conservador al inicio

REGLA DE ORO **Bloqueo: menisco** — Resonancia, no radiografía

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **59–62, 68–69** (págs. 15–16) · solucionario págs. 30–31.

Clase 12.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

12.9 Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

4.02.2.011 Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros) — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Esguince grado1 (acromioclavicular, dedos, rodilla y tobillo)

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Lesiones de Partes Blandas, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



CAJÓN ANTERIOR DEL TOBILLO
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.40

ALGORITMO · LESIÓN DE PARTES BLANDAS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

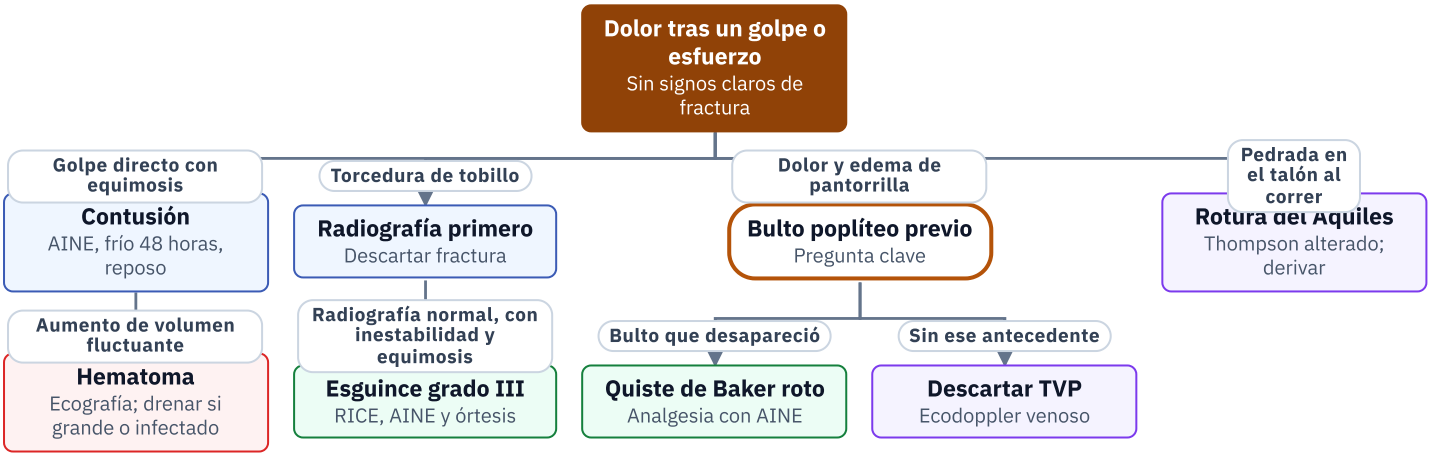


TABLA 12.9 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LESIONES DE PARTES BLANDAS

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

CUADRO	CLAVE	CONDUCTA
Contusión simple	Golpe directo, sin fractura	AINE, frío 48 horas y reposo
Hematoma	Fluctuante; ecografía	Drenar si es grande o se infecta
Esguince grado III	Equimosis e inestabilidad	RICE y órtesis, no cirugía

REGLA DE ORO **Contusión y hematoma: AINE, frío, reposo** — Frío 48 horas, luego calor

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **66–67, 73–74** (págs. 16–17) · solucionario págs. 31–32.

Clase 12.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

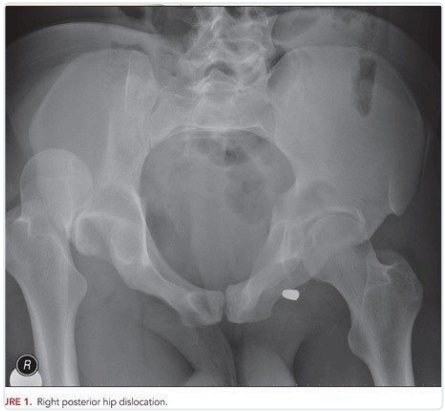
4.02.2.004
1.07.2.003
Fractura de cadera

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Radiografía de pelvis-caderas ante sospecha de fractura · Radiografía de pelvis y cadera · Tracción de partes blandas

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Fractura de Cadera en el Adulto Mayor, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



LUXACIÓN POSTERIOR DE CADERA
Atlas of Clinical Emergency Medicine (Sherman), p. 592

ALGORITMO · DOLOR DE CADERA TRAS UN TRAUMA EN ADULTO MAYOR

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

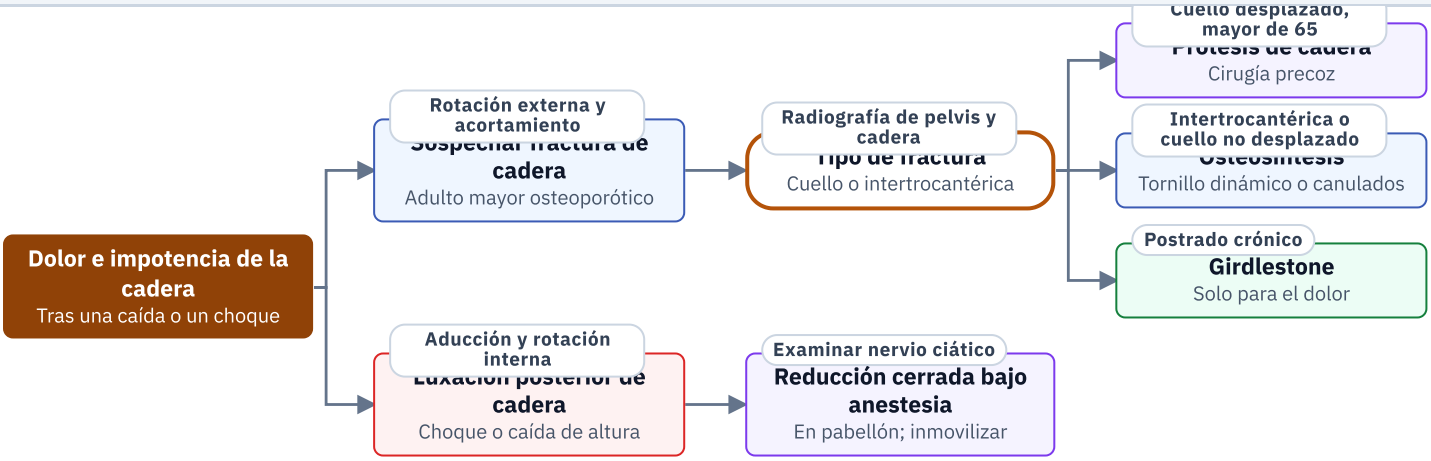


TABLA 12.10 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FRACTURA DE CADERA EN EL ADULTO MAYOR

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Adulto mayor, rotación externa y acortada	Fractura de cadera	Radiografía de pelvis y cadera; cirugía
Cuello desplazado, mayor de 65	Necrosis avascular probable	Prótesis de cadera
Choque, aducción y rotación interna	Luxación posterior	Reducción cerrada bajo anestesia

REGLA DE ORO **Impúdica: fractura; púdica: luxación** — Rotación externa contra aducción e interna

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **46–54** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 12.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA

12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

★★★ PRIORIDAD ALTA
12 preguntas reales 2013–2025

4.02.1.008 Síndrome de hombro doloroso — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Lumbago mecánico · Tendonitis y bursitis · Epicondilalgia, epitroclealgias · Lumbago infeccioso y tumoral · Infecciones osteoarticulares · Lumbociática radicular

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Patología Osteomuscular No Traumática, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.

ALGORITMO · DOLOR OSTEOMUSCULAR SIN TRAUMA

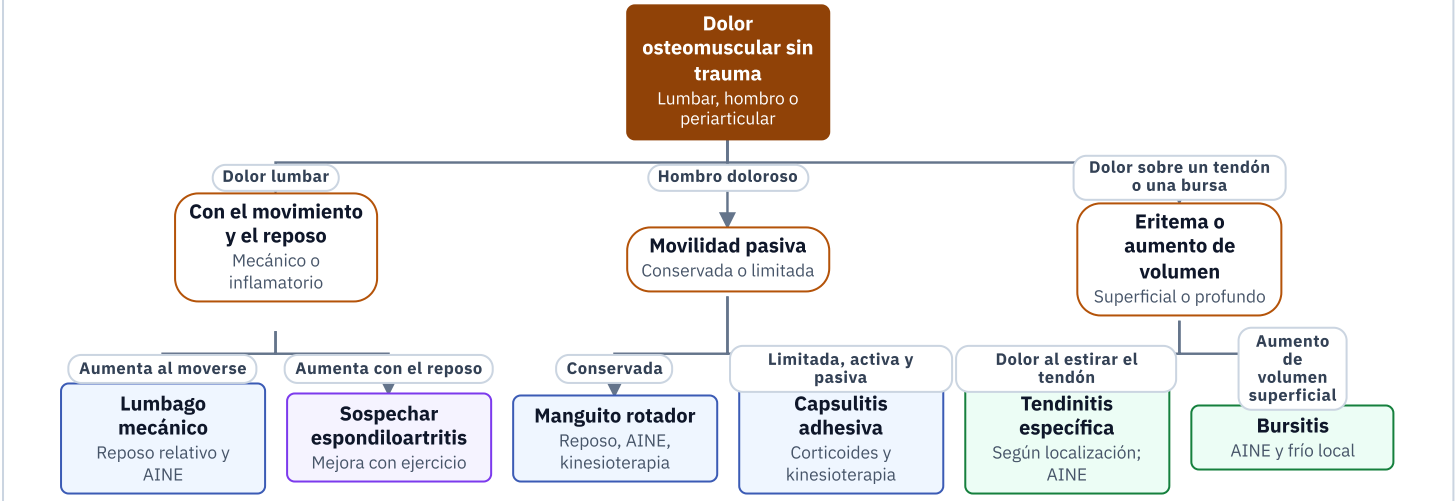


TABLA 12.11 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR NO TRAUMÁTICA

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DIAGNÓSTICO	MANEJO
Lumbago que mejora con ejercicio	Inflamatorio: espondiloartritis	Estudiar la causa
Lumbago que empeora al moverse	Mecánico	Reposo relativo, AINE; kinesioterapia después
Hombro: pasivo libre	Manguito rotador	Reposo, AINE, kinesioterapia

REGLA DE ORO **Mecánico: empeora al moverse** — Reposo relativo y AINE; kinesioterapia después

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **19, 86–87** (págs. 10, 18) · solucionario págs. 23, 35.

Clase 12.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

★★★ PRIORIDAD ALTA
18 preguntas reales 2013–2025

4.02.1.001 Artrosis primarias y secundarias — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

También: Monoartritis · Gota aguda · Citoquimico de líquido articular · Punción articular de rodilla · Infecciones osteoarticulares

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Artrosis & Monoartritis Aguda, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- **La sospecha clínica manda en trauma**: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.



COXARTROSIS EN LA RX
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 35.5

ALGORITMO · DOLOR ARTICULAR: ARTROSIS O MONOARTRITIS AGUDA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

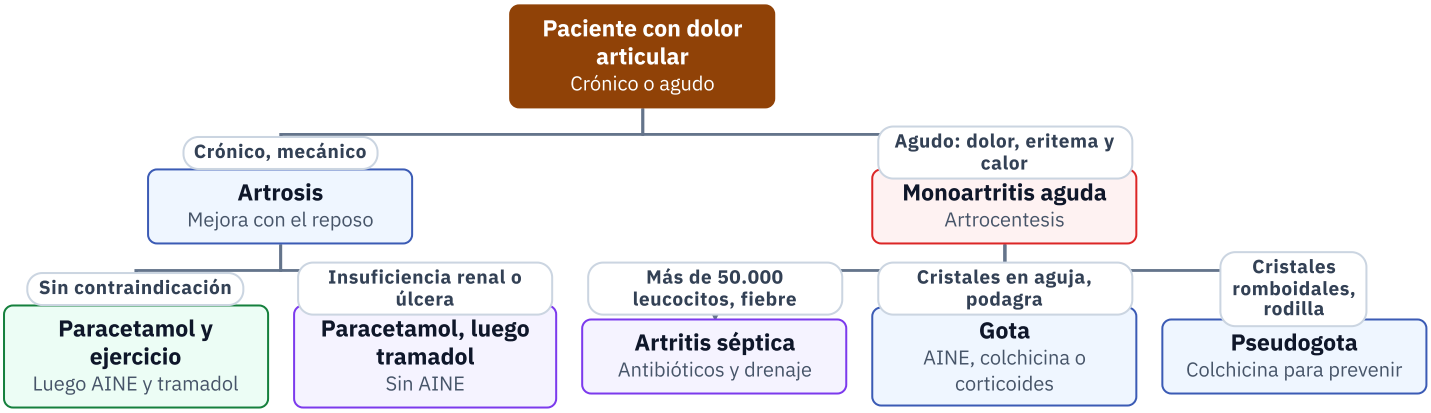


TABLA 12.12 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ARTROSIS & MONOARTRITIS AGUDA

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Dolor que mejora con el reposo	Artrosis	Paracetamol y ejercicio
Artrosis con IRC o úlcera	AINE contraindicados	Del paracetamol al tramadol
Articulación caliente	Monoartritis aguda	Artrocentesis

REGLA DE ORO **Paracetamol y ejercicio primero** — Luego AINE, tramadol, infiltración, prótesis

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **23–26, 63–65** (págs. 11, 15–16) · solucionario págs. 24, 30–31.

Clase 12.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

12.13 Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing

★★★ PRIORIDAD ALTA
14 preguntas reales 2013–2025

4.02.1.009 Tumores óseos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Radiografía en tumores oseos

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Tumores Óseos Benignos y Malignos, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.



OSTEOCONDROMA DEL PERONÉ
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 37.14

ALGORITMO · LESIÓN ÓSEA: BENIGNA O MALIGNA, Y CUÁL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

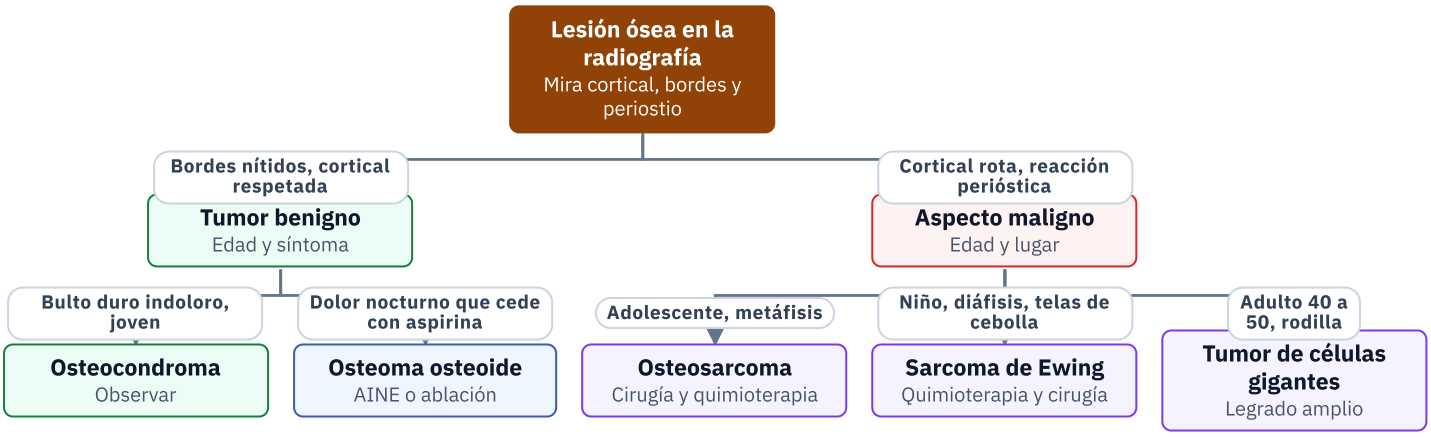


TABLA 12.13 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TUMORES ÓSEOS BENIGNOS Y MALIGNOS

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Joven, bulto duro indoloro	Osteocondroma	Observar
Dolor nocturno que cede con AINE	Osteoma osteoide	AINE; ablación si no cede
Adolescente, metáfisis, sol naciente	Osteosarcoma	Cirugía y quimioterapia

REGLA DE ORO **Osteocondroma: observar** — Cirugía si comprime o duele por roce

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **81–84** (pág. 18) · solucionario pág. 34.

Clase 12.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

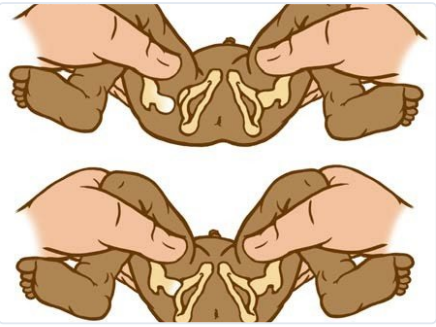
★★★ PRIORIDAD ALTA
11 preguntas reales 2013–2025

4.02.1.002 Displasia congénita de cadera — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Escoliosis y deformidades vertebrales · Alteraciones de los pies · Radiografía de displasia cadera · Pie plano · Disyunción-fractura del niño · Patología de columna

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Ortopedia Infantil, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.



MANIOBRA DE ORTOLANI
Nelson 22.ª ed., p. 5430

ALGORITMO · ORTOPEDIA INFANTIL: EDAD Y SIGNO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

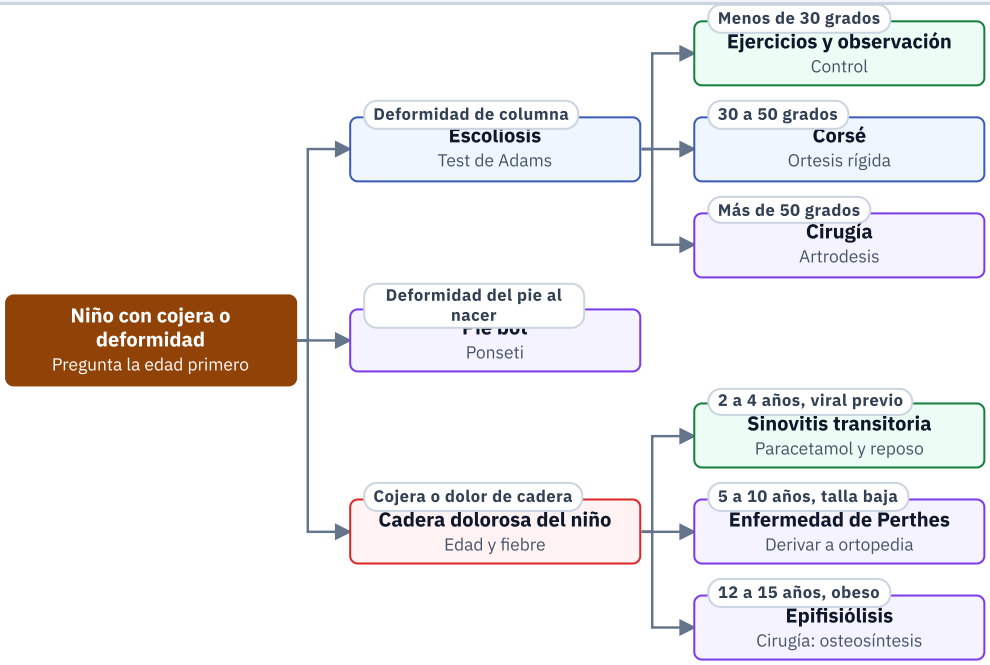


TABLA 12.14 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ORTOPEDIA INFANTIL

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

TRAMPAS EUNACOM

DATO	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
Giba costal al inclinarse	Escoliosis estructural	Rx y grados; corsé de 30 a 50

REGLA DE ORO **Displasia: mientras antes, mejor** — Pavlik, yeso y luego cirugía

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **1, 55–58, 70–72, 77–80** (págs. 8, 14–17) · solucionario págs. 20, 29, 32–33.

Clase 12.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

Muy Alta en EUNACOM · Cauda equina (anestesia en silla de montar + retención/incontinencia urinaria)

4.02.1.005
1.10.1.010
Lumbago mecánico

Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Síndrome de hombro doloroso · Cervicalgia · Lumbociática radicular · Radiografía de columna dorsal y lumbar · Lumbociáticas y cervicobraquialgias. · Hombro doloroso · Radiografía de columna vertebral

LO QUE TE PREGUNTAN

- En Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso, la evaluación neurovascular distal (pulsos, llenado capilar, sensibilidad motora) es obligatoria antes y después de inmovilizar.
- Toda fractura requiere al menos 2 proyecciones radiológicas perpendiculares (AP y Lateral), incluyendo las articulaciones proximal y distal.
- El dolor desproporcionado y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más precoces y sensibles de síndrome compartimental agudo.
- **Las fracturas expuestas constituyen emergencias quirúrgicas**: iniciar antibióticos EV en los primeros **60 minutos** y aseo quirúrgico urgente.
- En fracturas de cadera del adulto mayor, la cirugía en las primeras **24 a 48 horas** reduce significativamente la morbimortalidad y es garantía GES.
- **La sospecha clínica manda en trauma**: ante duda diagnóstica o luxación irreducible, derivar de urgencia a especialista traumatólogo.



PRUEBA DE SPURLING
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.4

ALGORITMO · DOLOR DE COLUMNA O DE HOMBRO

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

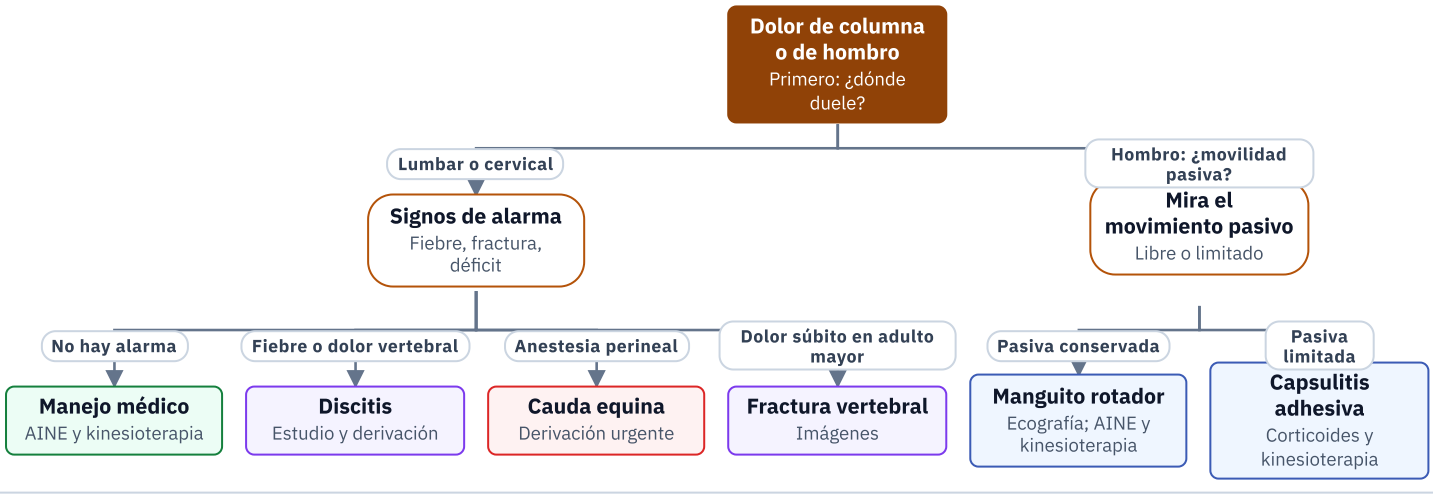


TABLA 12.15 · ENFRENTAMIENTO Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

PARÁMETRO CLÍNICO	CRITERIO DIAGNÓSTICO	SIGNO DE ALARMA	CONDUCTA TERAPÉUTICA
Evaluación Inicial	Anamnesis de energía del trauma + Deformidad visible	Compromiso neurovascular distal	Inmovilización provisoria inmediata
Estudio Radiológico	Radiografías en al menos 2 proyecciones (AP y Lateral)	Fractura intraarticular o luxación asociada	Reducción precoz o TAC complementario
Manejo Farmacológico	Analgesia multimodal escalonada (Paracetamol + AINEs / Opioides)	Dolor refractario o desproporcionado	Sospecha de síndrome compartimental
Criterio Quirúrgico	Desplazamiento inaceptable, inestabilidad o exposición	Lesión vascular o nerviosa aguda	Cirugía traumatológica de urgencia

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **37–38, 85, 88–90** (págs. 12, 18–19) · solucionario págs. 26, 34–35.

Clase 12.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA

12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TRAMPAS EUNACOM		
DATO	**DIAGNÓSTICO**	**CONDUCTA**
Lumbago mecánico sin alarma	Lumbago mecánico	AINE y kinesioterapia; sin RM
Fiebre y dolor vertebral	Discitis	Estudio y derivación
Anestesia en silla de montar	Cauda equina	Derivación urgente
Anciana con dolor súbito	Fractura vertebral	Estudio con imágenes
Arco doloroso, Neer positivo	Manguito rotador	AINE y kinesioterapia

REGLA DE ORO **Sin alarma: AINE y kinesioterapia** — Sin resonancia ni reposo en cama

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El dominio de Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso es un pilar fundamental en la práctica médica y en el examen EUNACOM. Su correcta evaluación semiológica permite distinguir los cuadros manejables en el nivel primario de aquellos que exigen reducción cerrada, estabilización urgente o intervención quirúrgica inmediata para preservar la función y viabilidad de la extremidad.

TABLA 12.15.B · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO Y FÁRMACOS EN LUMBAGO, CERVICALGIA & HOMBRO DOLOROSO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN PRIMARIA	FÁRMACOS / POSOLOGÍA	OBJETIVO CLÍNICO
Urgencia Inicial	Alineación anatómica e inmovilización provisoria	Analgesia EV (Ketoprofeno 100mg / Tramadol 50-100mg)	Alivio del dolor y prevención de daño secundario
Protección Cutánea	Aseo de heridas, apósitos estériles y férula	Cefazolina 2g EV + profilaxis antitetánica si expuesta	Prevención de infección osteoarticular profunda
Resolución Definitiva	Osteosíntesis interna (placas/tornillos/clavos) o prótesis	Tromboprofilaxis con HBPM (Enoxaparina 40mg/d SC)	Movilización precoz y consolidación ósea anatómica

ASÍ SE VE · FOTOS DE LA CLASE



COMPRESIÓN DE L1 EN LA TC
Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, p. 692



ARCO DOLOROSO
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.23 (b)



PRUEBA DE JOBE
Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 31.24

PRACTICA **Libro Gordo Traumatología**, preguntas **37–38, 85, 88–90** (págs. 12, 18–19) · solucionario págs. 26, 34–35.

Clase 12.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 15 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · GENERALIDADES DE FRACTURAS, FRACTURAS EXPUESTAS & COMPLICACIONES	
12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización	pág. 3
Espica de pulgar y repetir — Imagen a los **10 a 14 días** o resonancia	TIEMPO
Control radiográfico a los **5 a 7 días** — El yeso se afloja al ceder el edema	TIEMPO
12.2 Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente	pág. 4
Grado II: herida > **1 cm** — Habitualmente menor de **10 cm**	CORTE
12.3 Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente	pág. 6
Anticoagular y derivar — Heparina de bajo peso, luego oral por **3 meses**	TIEMPO
12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial	pág. 8
Heparina no fraccionada endovenosa — Bolo de **5.000 UI** u **80 UI**/kg	DOSIS
Reducción cerrada precoz — Cabestrillo **2 a 3 semanas**	TIEMPO
BLOQUE 02 · POLITRAUMA DEL APARATO LOCOMOTOR, PELVIS & RAQUIS	
12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz	pág. 9
Tórax: mediastino mayor de **8 cm** — Sospecha de lesión aórtica	CORTE
Sínfisis ensanchada más de **2,5 cm** — O sacroilíacas asimétricas	CORTE
Espacio prevertebral: más de **7 mm** en C2 — Más de **21 mm** en C6: hematoma	CORTE
BLOQUE 03 · EXTREMIDAD SUPERIOR, INFERIOR & CADERA	
12.7 Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince	pág. 12
Vendaje funcional y apoyo progresivo — Grado II: inmovilización semirrígida **1 a 2 semanas**	TIEMPO
PRICE: protección, reposo, hielo, compresión, elevación — Hielo **15 a 20 minutos** cada **2 a 3 horas**	TIEMPO
12.9 Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles	pág. 14
Frío **48 horas**, luego calor — Crioterapia al inicio	TIEMPO
12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía	pág. 15
Paciente mayor de **65 años** — Tercera condición	CORTE
Mortalidad a dos años: **50%** — Geriatría y traumatología se juntan	CORTE
Cuanto antes, mejor — Cirugía precoz, en las primeras **24 a 48 horas**	TIEMPO
12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis	pág. 16
AINE, analgesia y actividad — **80 a 90 %** mejora en **6 a 12 semanas**	TIEMPO
Cloxacilina o cefazolina EV por **4 a 6 semanas** — Vancomicina si hay SAMR; drenar absceso	TIEMPO
BLOQUE 04 · ORTOPEDIA INFANTIL, TUMORES & COLUMNA	
12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica	pág. 17
Drenaje y cloxacilina o cefazolina EV — Ceftriaxona si es gonococo; **2 a 4 semanas**	TIEMPO
Dosis: naproxeno, colchicina, prednisona — Naproxeno **500 mg** c/**12 h**; colchicina **1 mg** y **0,5 mg**; prednisona **30-40 mg**	DOSIS
12.13 Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing	pág. 18
Adultos de **40 a 50 años** — Fémur distal o tibia proximal	CORTE
12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño	pág. 19
Perthes y epifisiólisis — **5 a 10 años**; **12 a 15 años**	CORTE
I a V según el trazo — La II es la más frecuente, cerca de **75 %**	CORTE
I y II: yeso **3 a 4 semanas** — III y IV: reducción anatómica, derivar	TIEMPO
12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva	pág. 20
Lumbago agudo inespecífico: no — Salvo banderas rojas o más de **6 semanas**	TIEMPO

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
12.15 **Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva** (cont.)	pág. 20
Hernia discal y espondilosis — AINE, kinesiterapia y actividad en **6 a 12 semanas**	TIEMPO

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis		pág. 16
Epicondilalgia y epitroclealgia · Autolimitado, 6 a 12 meses	**Corticoide: alivia hoy, empeora mañana**	No se repite; cirugía excepcional
12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica		pág. 17
Gota · Crisis aguda	**AINE, colchicina o corticoides**	Los tres sirven en la crisis
Gota · Crisis aguda	**Dosis: naproxeno, colchicina, prednisona**	Naproxeno **500 mg** c/**12 h**; colchicina **1 mg** y **0,5 mg**; prednisona **30-40 mg**

GES de Traumatología y Ortopedia

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Politraumatizado / Urgencia Traumatológica de Alta Complejidad.**

Tema **12.2** · Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente
`4.02.2.008` · `4.02.5.001` · `4.02.5.005`
pág. **4**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Politraumatizado Grave con Riesgo Vital.**

Tema **12.5** · Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz
`4.02.2.006` · `4.02.2.014` · `4.03.2.009`
pág. **9**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Traumatismo Raquimedular.**

Tema **12.6** · Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa
`4.02.2.007`
pág. **11**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Tratamiento Quirúrgico de la Fractura de Cadera en mayores de 65 años.**

Tema **12.9** · Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles
`4.02.2.011` · `4.02.2.003`
pág. **14**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Tratamiento Médico en personas de 55 años y más con Artrosis de Cadera o Rodilla.**

Tema **12.11** · Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis
`4.02.1.008` · `4.02.1.005` · `1.11.1.024`
pág. **16**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Displasia del Desarrollo de la Cadera · Radiografía de pelvis a los 3 meses.**

Tema **12.13** · Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing
`4.02.1.009` · `4.02.4.005`
pág. **18**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer en menores de 15 años · Alivio del dolor por cáncer avanzado.**

Tema **12.14** · Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño
`4.02.1.002` · `4.02.1.003` · `2.01.1.091`
pág. **19**

Sin garantía GES específica (8 temas): 12.1 · 12.3 · 12.4 · 12.7 · 12.8 · 12.10 · 12.12 · 12.15. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

3 temas · ★★★

- ★★★ **12.12** Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica — 17
- ★★★ **12.13** Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing — 18
- ★★★ **12.4** Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial — 8

Practica: Libro Gordo Traumatología, preguntas 21–26, 41–42, 63–65, 81–84.

DÍA 2

3 temas · ★★★

- ★★★ **12.11** Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis — 16
- ★★★ **12.1** Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización — 3
- ★★★ **12.14** Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño — 19

Practica: Libro Gordo Traumatología, preguntas 1, 3–9, 19, 39–40, 55–58, 70–72, 77–80, 86–87.

DÍA 3

3 temas · ★★

- ★★☆ **12.5** Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz — 9
- ★★☆ **12.10** Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía — 15
- ★★☆ **12.9** Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles — 14

Practica: Libro Gordo Traumatología, preguntas 20, 27–31, 46–54, 66–67, 73–74.

DÍA 4

2 temas · ★★

- ★★☆ **12.15** Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva — 20
- ★☆☆ **12.7** Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince — 12

Practica: Libro Gordo Traumatología, preguntas 37–38, 43–45, 76, 85, 88–90.

DÍA 5

2 temas · ★

- ★☆☆ **12.8** Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral — 13
- ★☆☆ **12.3** Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente — 6

Practica: Libro Gordo Traumatología, preguntas 14–18, 59–62, 68–69.

DÍA 6

2 temas · ★

- ★☆☆ **12.6** Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa — 11
- ★☆☆ **12.2** Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente — 4

Practica: Libro Gordo Traumatología, preguntas 10–13, 32–34.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 22
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 12.1 · 12.4 · 12.11 · 12.12 · 12.13 · 12.14
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Traumatología en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 6 temas

18 12.12. Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica 17

14 12.13. Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing GES 18

13 12.4. Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial 8

12 12.11. Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis GES 16

11 12.1. Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización 3

11 12.14. Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño GES 19

★★ Prioridad media · 4 temas

7 12.5. Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz 9
GES

6 12.10. Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía 15

5 12.9. Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles GES 14

5 12.15. Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva 20

★ Prioridad baja · 5 temas

4 12.7. Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince 12

4 12.8. Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral 13

3 12.3. Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente 6

3 12.6. Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa GES 11

0 12.2. Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente GES 4